Evaluar la promoción de la salud y la acción local

SESIÓN 3 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Propuesta docente en revisión: 31/10/2026. Pendiente de validación institucional.

Preguntas de evaluación, seguimiento y evaluación, registros de actividad, métodos cualitativos y devolución.

Qué aprenderemos

- Formular preguntas de evaluación útiles para quien va a usar los resultados.
- Distinguir seguimiento y evaluación, y evaluación de proceso, resultados e impacto.
- Reconocer qué puede y qué no puede afirmar un registro de actividad.
- Construir una matriz de evaluación y revisarla con la lista de comprobación de evaluación.
- Planificar la devolución de resultados y su uso en el siguiente ciclo.

Agenda

09:00–09:30
Retorno del trabajo T2

09:30–10:20
Para qué y para quién se evalúa. Proceso, resultados e impacto. Contribución y atribución

10:20–11:15
Registros de actividad: el caso RAPS. Entregas y consolidación de indicadores

11:15–11:45
Descanso

11:45–12:45
Taller: matriz de evaluación del caso y lista de comprobación de evaluación

12:45–13:30
Métodos cualitativos y participativos. Informe, devolución y cierre del ciclo

13:30–14:00
Cuestionario final, evaluación del curso y presentación del trabajo T3

1. Seguimiento y evaluación

¿Estamos haciendo lo que planificamos?
Tipo: Seguimiento de proceso · Compara con: Lo planificado

¿Llega a quien debía llegar y como estaba previsto?
Tipo: Evaluación de proceso · Compara con: El diseño de la actuación

Evaluar la promoción de la salud y la acción local

SESIÓN 3 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

¿Han cambiado los determinantes, conocimientos, conductas o condiciones?
Tipo: Evaluación de resultados · Compara con: El tiempo cero

¿Ha mejorado la salud de la población?
Tipo: Evaluación de impacto · Compara con: El tiempo cero y, si es posible, un territorio de comparación

Contribución y atribución

En un plan local de cuatro años rara vez puede atribuirse un cambio en la salud de la población a las actuaciones del plan: influyen otros factores y el tamaño de la población limita la precisión. Lo razonable suele ser evaluar el proceso con exhaustividad, los resultados intermedios con rigor y el impacto como contribución plausible, declarando los límites. Prometer impacto atribuible que no podrá demostrarse debilita la credibilidad del plan.

Dimensiones útiles (marco RE-AIM)

Alcance
¿Qué proporción de la población destinataria participó? ¿Quién quedó fuera?

Efectividad
¿Qué cambió en quienes participaron?

Adopción
¿Qué entidades y profesionales se sumaron?

Implementación
¿Se hizo lo previsto? ¿Qué se adaptó y por qué?

Mantenimiento
¿Continúa la actuación cuando termina el apoyo inicial?

2. Qué dice un registro de actividad

El RAPS (Registro de Actuaciones de Promoción de la Salud) recoge en REDCap las actividades de promoción de la salud que registran los profesionales del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano y permite explorarlas por distrito, unidad y profesional, con procesamiento local en el navegador. Un registro así es una buena fuente para el seguimiento de proceso.

- Puede informar: qué actividades se hicieron, dónde, cuándo, con qué temática y cuántas sesiones.
- Requiere cautela: la exhaustividad depende de que se registre todo lo realizado; sin registro no se puede afirmar que algo no se hizo.
- No puede informar por sí solo: si las personas cambiaron sus conductas o si mejoró su salud.
- Asistencias no equivalen a personas: sin identificador único no se eliminan duplicados.

Evaluar la promoción de la salud y la acción local

SESIÓN 3 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

3. Matriz de evaluación

Pregunta de evaluación
Qué se quiere saber y para qué decisión

Indicador o información
Cuantitativa o cualitativa

Fuente e instrumento
Registro, cuestionario, entrevista, grupo, observación

Momento
Tiempo cero, durante la ejecución, al final, seguimiento

Responsable
Cargo

Uso previsto
Quién recibirá el resultado y qué podrá decidir con él

Lista de comprobación de evaluación de EpS grupal

33 ítems en seis secciones: planificación de la evaluación, proceso, resultados, impacto, instrumentos, y análisis y uso de resultados. Se aplica a la actuación grupal revisada en T2. Ítems que suelen fallar: línea base asegurada antes de empezar, instrumentos pilotados, estrategia para reducir pérdidas de seguimiento y devolución de resultados a participantes.

4. Métodos cualitativos y participativos

- Grupos de discusión y entrevistas: por qué funcionó o no, para quién y en qué condiciones.
- Técnica del cambio más significativo: relatos de cambio seleccionados colectivamente.
- Observación y diario de campo de las actividades.
- Evaluación con la comunidad: el Grupo Motor y los participantes interpretan los resultados, no solo los reciben.

Devolución y cierre del ciclo

El informe de evaluación tiene al menos tres destinatarios: el Grupo Motor y la corporación (decisiones), los equipos que ejecutan (mejora) y la comunidad (rendición de cuentas). Cada uno necesita un formato distinto. La evaluación final es el punto de partida del siguiente diagnóstico: lo que se midió con la misma definición se convierte en serie temporal.

Evaluar la promoción de la salud y la acción local

SESIÓN 3 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Criterio de cierre

Cada grupo presenta tres preguntas de evaluación de su plan y explica con qué información responderá a cada una y quién usará la respuesta.

El caso Sierranueva es ficticio: sus datos son inventados para la docencia. No incorporar datos personales ni información clínica individual en los trabajos.